

KC桌面——外资精译

Bernstein：中国制药与生物技术亚洲生物医药夏季研讨会  
探讨GLP

肥胖市场正进入下一阶段，竞争已超越减重疗效。虽然下一代注射疗法已将安慰剂调整后的减重幅度推至20%以上，但差异化正日益转向更广泛的代谢获益、肌肉保存和便利性。我们认为，未来的赢家不仅将带来卓越的减重效果，还将解决心血管、肾脏、肝脏和身体成分结局。

口服GLP-1和长效疗法正在扩展治疗工具箱。虽然注射疗法仍提供最强疗效，但口服GLP-1正为寻求更便捷给药和中等程度减重的患者创造有吸引力的替代方案。礼来的Foundayo（orforglipron）和诺和诺德的口服司美格鲁肽已证明，口服疗法可实现约10%的减重，这对许多患者而言可能已足够。Foundayo的小分子设计提供了额外便利，因为它避免了与肽类口服司美格鲁肽相关的严格空腹要求。在中国项目中，信达生物的IBI3032在仅四周内实现8.6%的安慰剂调整后减重，已成为值得关注的竞争者，而每周一次的口服候选药物IBI3042则凸显了行业在不大幅牺牲疗效的前提下降低给药频率的更广泛努力。

新兴疗法旨在超越传统GLP-1疗法，延长作用持久性。抗体-肽偶联物（APC）、环状RNA疗法和基因疗法正被开发以实现每月一次给药或单次给药后实现持久的代谢控制。安进的MariTide目前提供了最先进的概念验证，而信达生物和派格生物等中国创新企业正积极布局这些下一代平台。

尽管存在定价不确定性，我们仍预计到2030年，中国GLP-1市场规模约为850亿元人民币。尽管价格加速下滑且围绕肥胖药物处方的监管审查日益严格，潜在需求依然强劲。我们已调整市场假设，以反映较低的长期定价，但更高的渗透率和更广泛的适用人群，因此对2030年中国GLP-1市场约850亿元人民币的估计保持不变。从2027年开始的一波主要上市浪潮应会进一步扩大患者可及性并加速市场渗透。我们认为，行业下一阶段的增长将由疗效、代谢获益、身体成分、便利性和可负担性共同驱动，而非任何单一属性。

注：礼来和安进由Courtney Breen覆盖，诺和诺德由Justin Smith覆盖。

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖  
6990.HK、9688.HK的估值为EV/Sales（倍）；9926.HK、1093.HK、1177.HK的基准年为2024年

来源：彭博、Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予百奥泰、翰森制药、信达生物、恒瑞医药和科伦博泰“跑赢大盘”评级，给予康方生物、石药集团、三生制药和再鼎医药“与大市同步”评级。

详细内容：公司情况更新

传统上，围绕GLP-1疗法的讨论一直以临床疗效、安全性和商业应用为主导。然而，随着这一类别从早期使用者扩展到更广泛的肥胖和代谢健康市场，了解消费者自身如何评估这些产品同样重要。为准备本次GLP-1研讨会，我们回顾了一系列患者和消费者偏好研究，并确定了几个始终作为影响治疗选择最重要因素的主题。

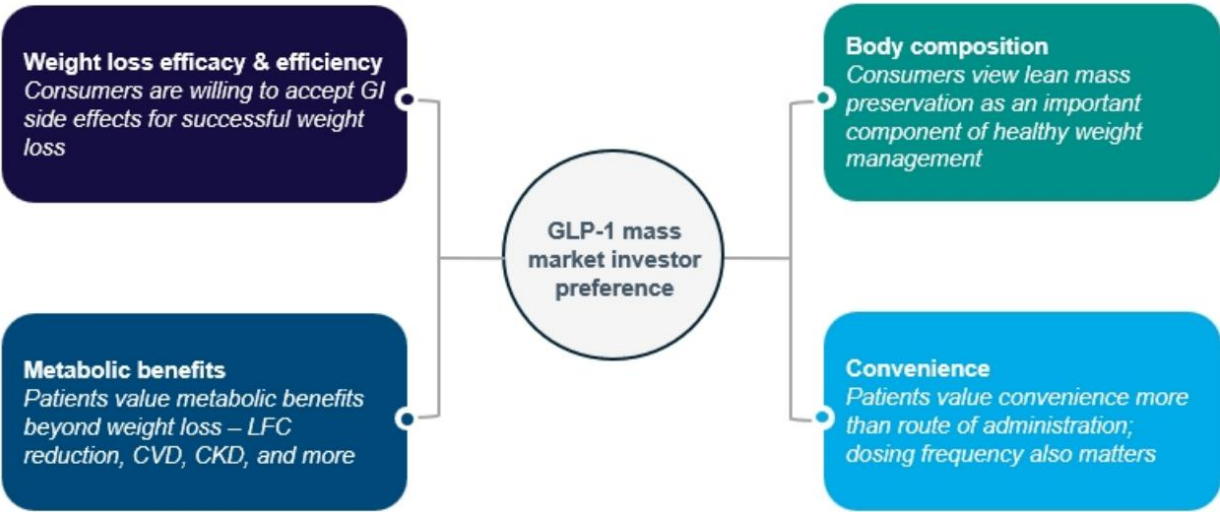
首先，减重疗效仍然是唯一最重要的属性。多项研究表明，患者愿意在短期内忍受胃肠道副作用，如果这能转化为更有意义的减重效果。换句话说，一旦安全性被认为可接受，疗效往往成为偏好的主要决定因素。这反映了一个现实，即许多患者将减重视为核心治疗目标，并愿意做出权衡以获得更好的结果（来源）。

其次，消费者越来越关注代谢和身体成分获益。更广泛的代谢和身体成分获益正受到更多关注。肌肉保存、内脏脂肪减少和整体减重质量等指标正成为重要的差异化因素，因为消费者寻求更健康、更可持续的结果，而不

仅仅是最大化减重磅数（来源1，来源2）。

最后，便利性。口服疗法是传统皮下注射形式之后的一种演变，公司也在探索长效制剂。基于这些主题，我们的GLP-1研讨会将聚焦于这些可能塑造GLP-1领域下一阶段竞争的关键领域。

图表1：在选择GLP-1产品时，减重、便利性、身体成分/代谢获益是读者的关键偏好



图表 1

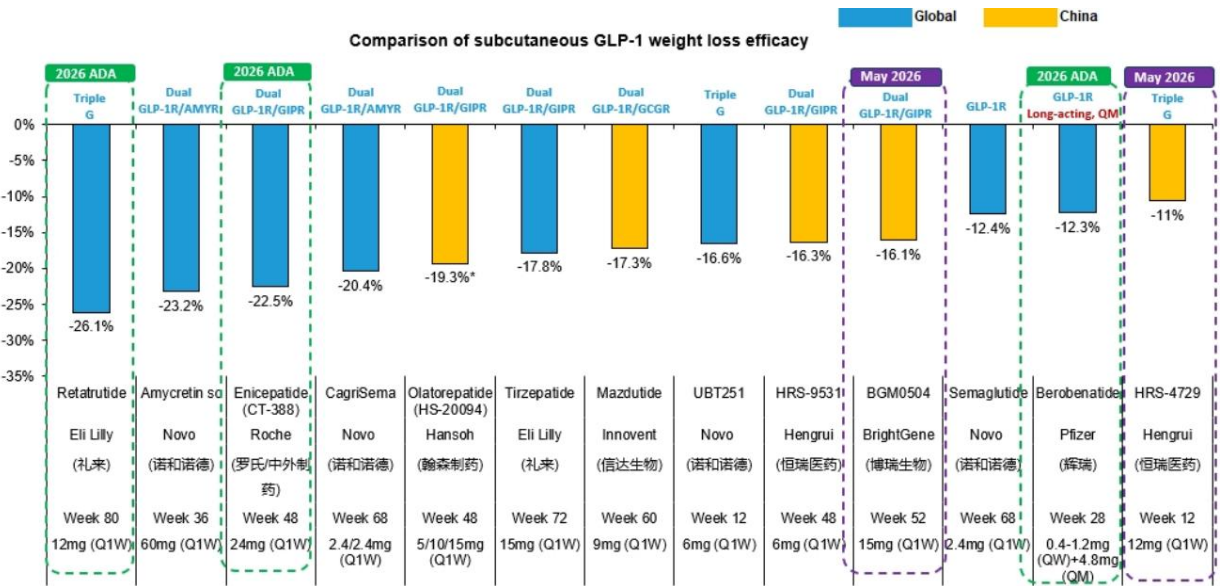
来源：Diabetes Obes Metab、Patient Preference and Adherence、Scandinavian Journal of Primary Health Care、Patient Care、Bernstein分析

第一部分：减重疗效与效率

减重的疗效基准已从安慰剂调整后的-10%演变至超过-20%。仅在几年前，市场还将实现超过10%的安慰剂调整后减重视为重大突破，司美格鲁肽以约12.4%的水平树立了新标准。此后，创新步伐急剧加速。替尔泊肽将安慰剂调整后减重推至接近18%，而新一代候选药物——包括retatrutide、皮下amycratin、enicapatide（CT-388）和CagriSema——已在临床研究中显示出超过20%的安慰剂调整后减重。因此，竞争格局正进入一个新阶段，多种疗法都能实现类似水平的显著减重。

注：诺和诺德和罗氏由Justin Smith覆盖；礼来和辉瑞由Courtney Breen覆盖

图表2：皮下GLP-1竞争格局



图表 2

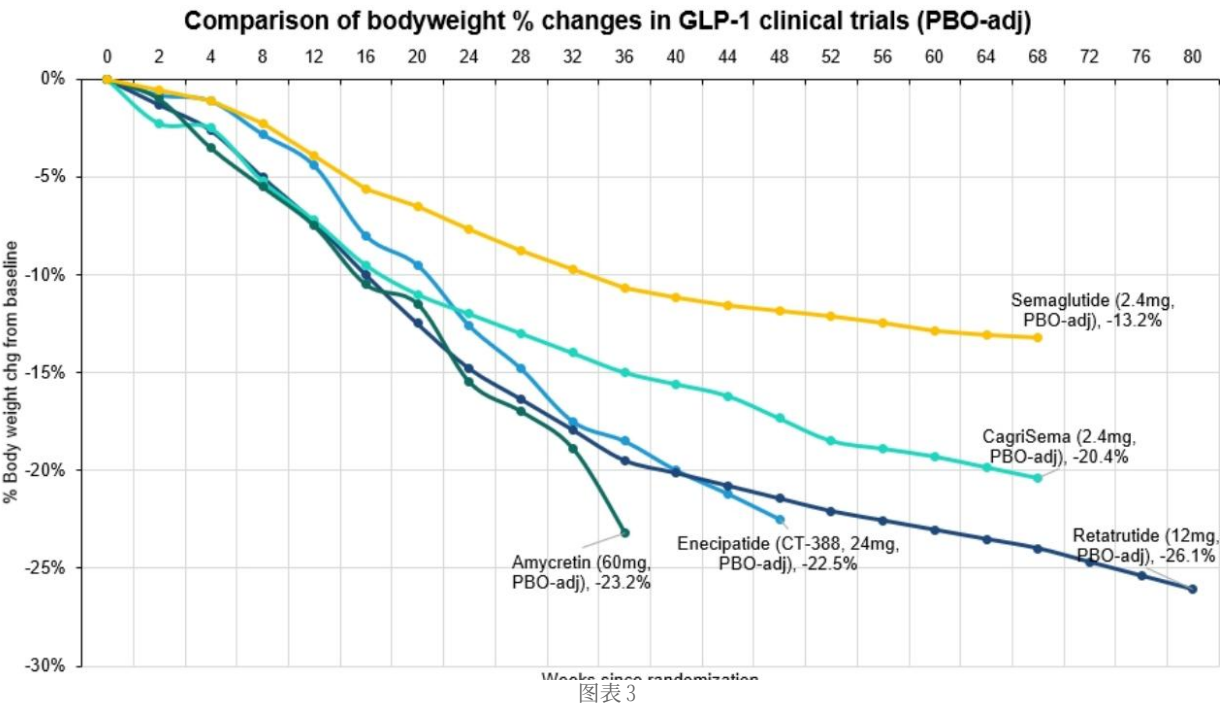
- 玛仕度肽的GLORY-2（9mg）和CagriSema的REDEFINE-1结果（2026年ADA）与先前报告相同；2）HS-20094：可能非安慰剂调整；礼来和辉瑞由Breen Courtney覆盖，诺和诺德和罗氏由Justin Smith覆盖，博瑞医药未覆盖

来源：公司披露、ADA、EASD、Bernstein分析

在主要候选药物中，retatrutide 在第 80 周实现了约 26.1% 的安慰剂调整后减重，而皮下注射的 amycratin 和 enicepatide (CT-388) 在第 36 至 48 周分别实现了约 23.2% 和 22.5% 的减重。CagriSema 在第 68 周也展现出强劲疗效，实现了约 20.4% 的安慰剂调整后减重。重要的是，差异并不仅限于最终的减重结果。减重轨迹显示，这些药物在治疗相对早期就开始相互区分，部分候选药物在大约 16 至 24 周时即实现两位数减重，此后差距持续扩大。这表明新一代疗法不仅实现了更大的绝对减重，而且以更快的速度带来了有意义的疗效（图表 3）。

与在第 68 周实现约 12.4% 安慰剂调整后减重的 semaglutide 相比，领先的下一代药物在治疗的最初几周就开始显现出明显差异，并在 10 至 20 周的时间范围内差异愈发显著。从机制上看，这与行业从单一靶点 GLP-1 激动剂转向多靶点方法（涉及互补代谢通路，如 GLP-1/GIP、GLP-1/amylin 甚至三重 G 机制）的趋势一致。因此，这些疗法似乎不仅仅是 semaglutide 的渐进式改进；它们反映了代谢调节强度和广度的全面提升。从商业角度看，更早起效也可能是一个重要优势。在治疗最初几周内就体验到明显减重的患者更可能认为疗法有效，这有助于提高依从性、持续性，并最终实现长期治疗保留。

图表 3：领先的皮下注射 GLP-1 药物可实现 >20% 的减重，从治疗早期阶段就展现出优于 semaglutide 的疗效  
GLP-1 临床试验中体重百分比变化的比较（安慰剂调整后）



来源：公司披露、《新英格兰医学杂志》、《柳叶刀》、Bernstein分析

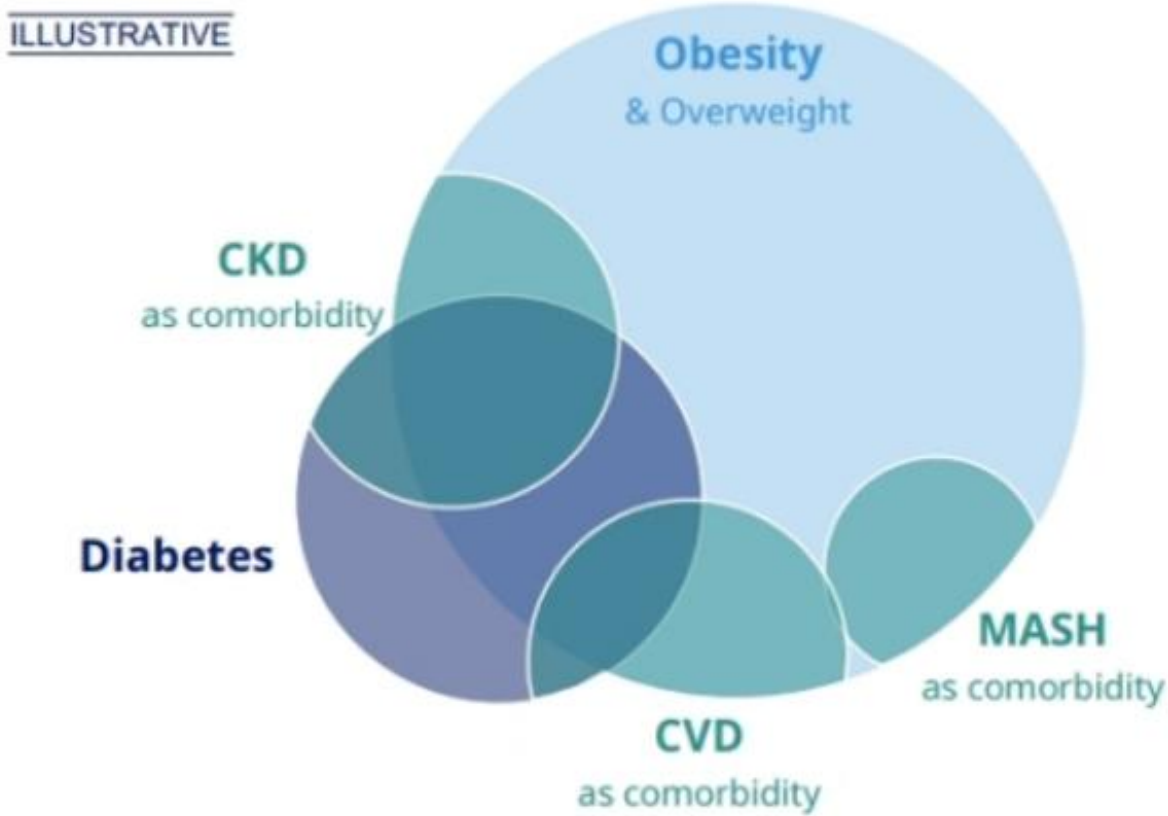
## 第二部分：代谢获益

肥胖、糖尿病、CKD、CVD 和 MASH/MAFLD 之间存在大量患者重叠，这些疾病通常作为共同潜在代谢功能障碍的表现形式共存。肥胖是这些疾病的已知不确定性因素和常见合并症。例如，约 44% 的 CKD 患者同时患有肥胖，39% 的肥胖患者患有 MAFLD。因此，使用 GLP-1 药物治疗肥胖已带来代谢获益，从而缓解了上述其他疾病（图表 4）。

图表 4：肥胖、糖尿病、CKD、CVD 和 MASH 之间存在大量重叠人群

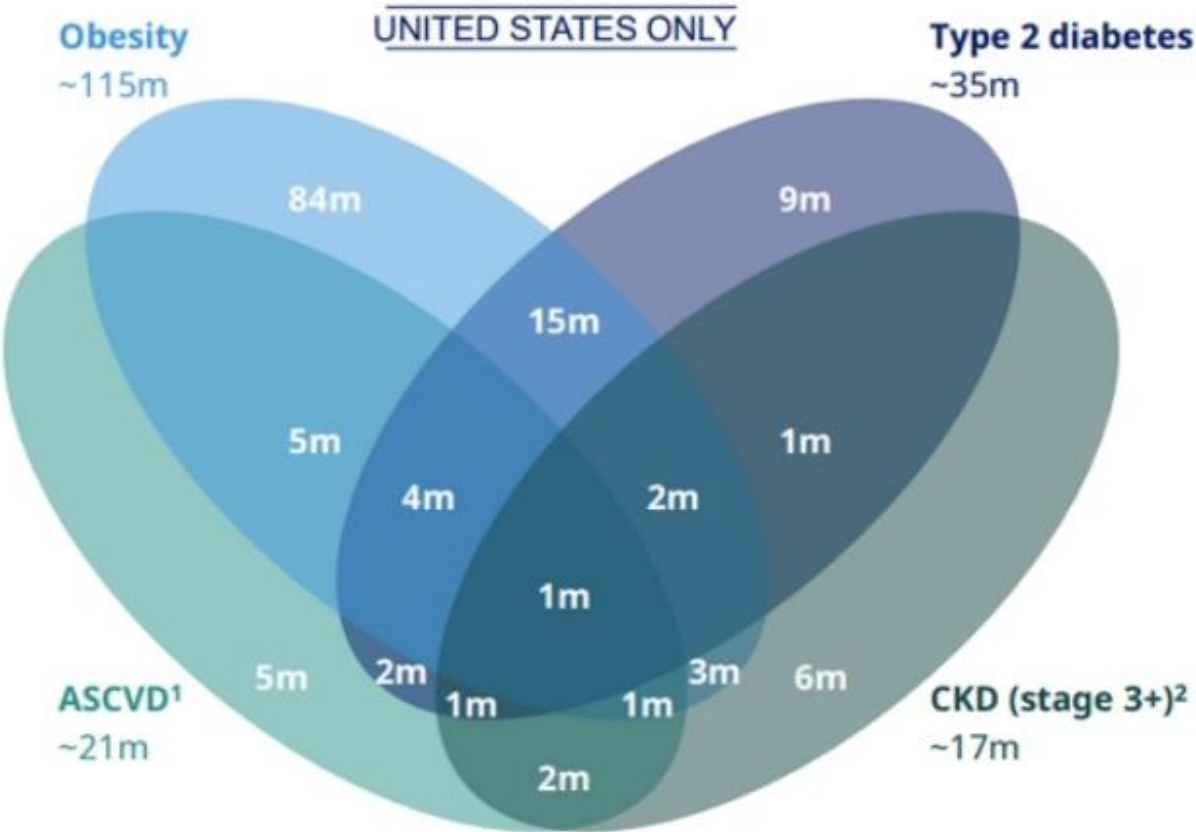


重点将放在核心治疗领域和优先解决未满足的需求，包括合并症



图表 4

来源：诺和诺德 2 型糖尿病关键关注领域的患者重叠情况



图表 5

肥胖市场正日益超越单纯的减重范畴，GLP-1 疗法在越来越多的合并症中展现出获益，包括心血管疾病、慢性肾病、心力衰竭、MASH

和阻塞性睡眠呼吸暂停。Semaglutide 迄今已建立了最广泛的证据基础，在心血管、肾脏疾病和 MASH 方面拥有获批适应症和阳性结果，而 tirzepatide 则在 MASH 和 OSA 方面产生了特别强劲的数据。这些发现强化了以下观点：肥胖是一种全身性疾病，GLP-1 疗法可以在多个器官系统带来具有临床意义的获益，有可能将可治疗的患者群体扩大到远超单纯寻求减重的人群。

展望未来，下一代药物旨在通过增强疗效和更广泛的心血管代谢获益来进一步实现差异化。在新兴疗法中，mazdutide 和 retatrutide 尤为突出，尤其是在肝脏相关结局方面，它们对肝脏脂肪含量的安慰剂调整后降幅分别约为 81% 和 83%——显著高于 semaglutide 或 tirzepatide 的报告数据。Retatrutide 在 OSA 和骨关节炎方面也显示出有希望的数据，而几项正在进行的 3 期结局研究将确定这些疗效优势是否能转化为卓越的心血管和肾脏保护。随着该领域的成熟，竞争可能会从单纯的减重转向对肥胖相关并发症总体代谢获益的更全面评估。

试验已完成且适应症已获批 试验数据阳性但尚未获批 正在进行试验，等待结果 图表  
5：获批适应症：CVD、CKD、MASH、OSA 等，更多参与者正在进入该领域

结果均为安慰剂调整后数据，MASH 患者应答除外；OA=骨关节炎，OSA=阻塞性睡眠呼吸暂停，AD=阿尔茨海默病，CVD=心血管疾病，HFpEF=射血分数保留的心力衰竭，CKD=慢性肾病

测量指标：KCCQ-CSS=堪萨斯城心肌病问卷-临床总结评分；AHI=呼吸暂停-低通气指数；WOMAC=西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数

来源：公司披露、《新英格兰医学杂志》、《柳叶刀》、Clinicaltrials.gov、Bernstein分析

除了减重，基于 GLP-1 的疗法可能提供一系列重要的代谢和心血管获益。在合并的 mazdutide 组中，与安慰剂组相比，参与者在治疗 48 周后多个心血管代谢不确定性因素方面获得了显著更大的改善。Mazdutide 使调整压降低了 8.56 mmHg，而安慰剂组降低了 2.13 mmHg，治疗差异为 -6.44 mmHg。在血脂参数（包括甘油三酯、总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇）方面也观察到类似的获益，所有这些指标在 mazdutide 组的下降幅度均大于安慰剂组。

此外，mazdutide 在代谢和肝脏相关生物标志物方面显示出有利影响。Mazdutide 组的血清尿酸水平降低了 36.7  $\mu\text{mol/L}$ ，而安慰剂组则升高了 7.91  $\mu\text{mol/L}$ ；同时，肝功能标志物丙氨酸氨基转移酶在 mazdutide 组显示出更大幅度的降低。这些发现表明，GLP-1 受体激动剂疗法的临床获益不仅限于减重，还有助于改善心血管、代谢和肝脏健康（图表 6）。

图表 6：其他代谢获益



图表 6

来源：《新英格兰医学杂志》、Bernstein分析

### 第三部分：身体成分

#### 3/5：公司情况更新

超越GLP-1的核心差异化：保持瘦体重。展望未来，GLP-1领域的下一阶段创新日益以保持瘦体重而非单纯减重来定义。Amylin疗法已成为一种关键的差异化方法，在实现合理减重的同时，展现出更好的瘦体重保持效果，

其脂肪与瘦体重比率约为3:1——显著优于传统GLP-1药物。从机制上看，amylin的肠脑信号传导使患者在饱腹前仍能享受进食乐趣，可能避免GLP-1疗法中常见的恶心和厌食症状。除amylin外，激活素通路中的靶点正受到关注：ActRII类（如bimagrumb和LAE102）已显示出在诱导合理减重的同时实现瘦体重绝对增加的能力；另一方面，INHBE/ALK7相关疗法（如ARO-INHBE和WVE-007）似乎更倾向于增加瘦体重。然而，尽管bimagrumb在减重的同时增加了瘦体重，但它是一种静脉注射疗法，且礼来公司在2025年因战略业务原因在招募患者前终止了一项2b期肥胖症试验，不过bimagrumb仍在“一项正在进行的与替尔泊肽联用的肥胖症患者2期试验中进行研究”（来源）。

拓展疗效前沿：联合、口服及三重激动剂策略。与此同时，业界正在探索多种战略方向以提升GLP-1药物的疗效和可用性。将GLP-1与互补机制（包括amylin、ActRII和INHBE）相结合的联合治疗方案，旨在实现更显著的减重效果（可能超过20%），同时部分减轻瘦体重流失。口服制剂，包括Wegovy口服片和orforglipron，越来越多地被定位用于长期维持治疗，以解决慢性体重管理中的依从性和便利性问题。与此同时，三重激动剂（GLP-1/GCCR/GIP）有望实现最大幅度的减重；然而，这一益处伴随着更高的瘦体重流失预期。

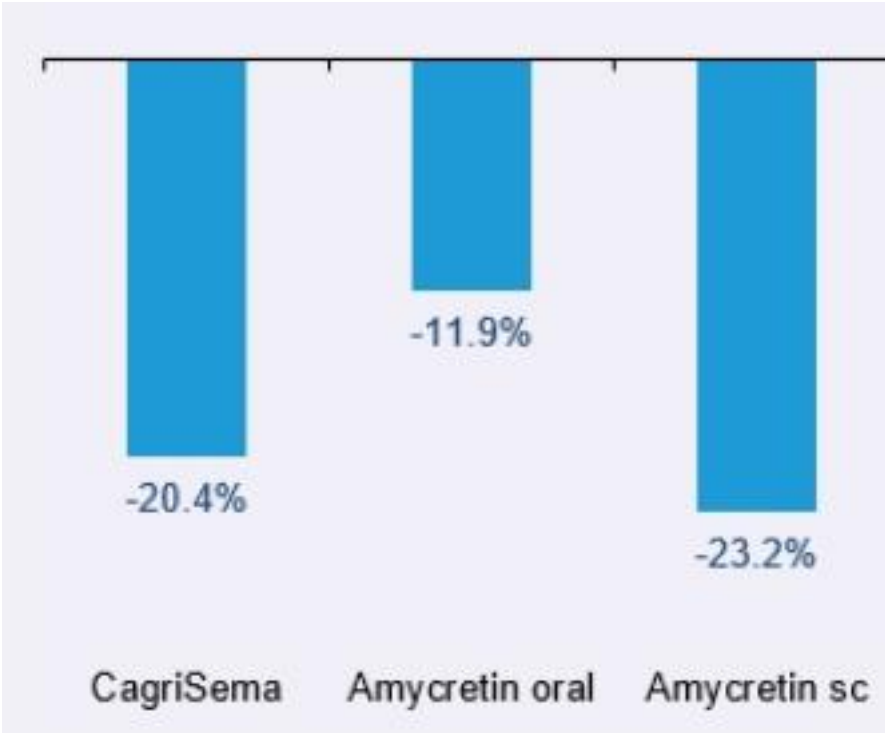
图表7：新兴肥胖疗法提供了广泛的个性化减重选择

√ 表示中等程度减重和均衡的瘦体重保持 来源：公司披露，柳叶刀，美国糖尿病协会，Bernstein分析

图表8：新兴疗法与GLP-1治疗联用时效果更佳

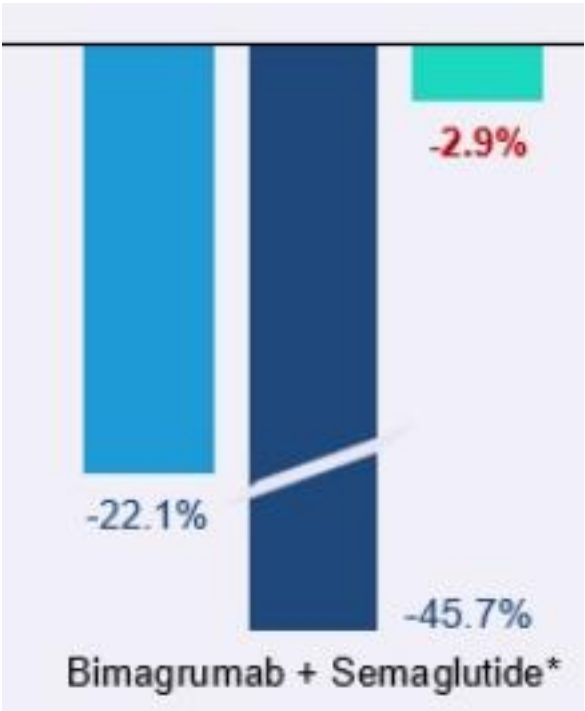


图表 7



图表 8

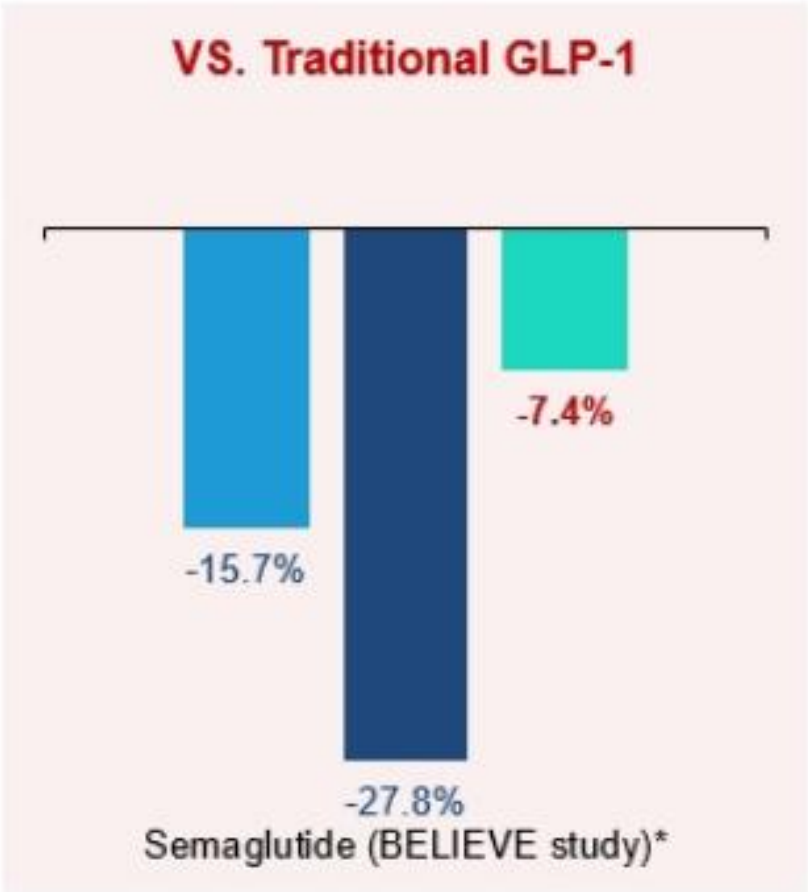
带\\*的名称未经安慰剂校正



图表 9



图表 10



图表 11

来源：公司披露，柳叶刀，美国糖尿病协会，Bernstein分析

第四部分：便利性

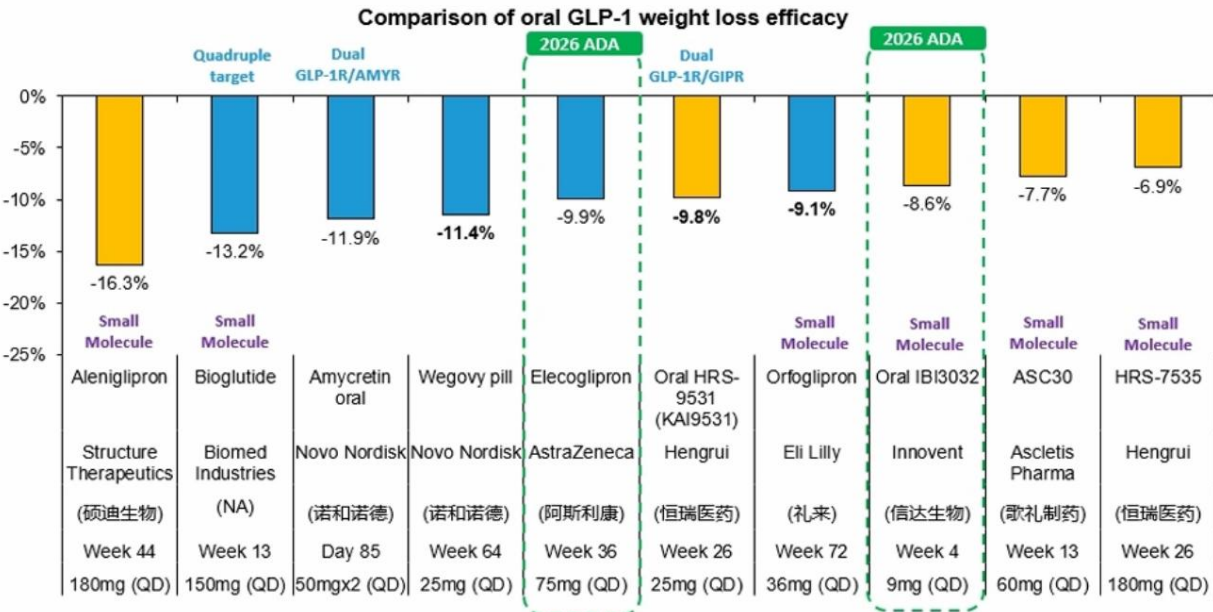
注射型GLP-1疗法仍然是减重最有效的选择，领先产品可实现十几到二十个百分点（mid- to high-teens）的体重降幅。口服疗法通常疗效略低，但近期数据表明，许多候选药物仍可实现约10%的减重效果。因此，对于不追求最高减重幅度但看重每日口服片剂相比注射剂便利性的患者而言，口服药物可能是一个不错的选择。

在口服疗法中，Foundayo（orforglipron）因其小分子设计而与众不同。口服司美格鲁肽（Wegovy口服片）是一种多肽，必须在严格的空腹条件下服用，而Foundayo则无需相同的饮食限制，服用更为方便。这种更简便的给药方式，加上约10%的减重效果，可能使Foundayo成为寻求使用便利性而非最大减重效果患者的理想替代选择。

另一款备受关注的口服GLP-1候选药物是信达生物的IBI3032。尽管仍处于早期开发阶段，这款每日一次的口服小分子疗法在短短四周内实现了令人印象深刻的8.6%安慰剂校正减重效果，其疗效幅度可与一些竞争对手治疗数月后的效果相媲美。虽然应谨慎解读跨试验比较结果，且仍需更长期的数据来评估其持久性，但IBI3032所展现的快速起效特点表明，如果后续研究证实这些早期结果，它可能成为口服肥胖症市场中极具竞争力的新进入者。

图表9：口服GLP-1减重疗效竞争格局





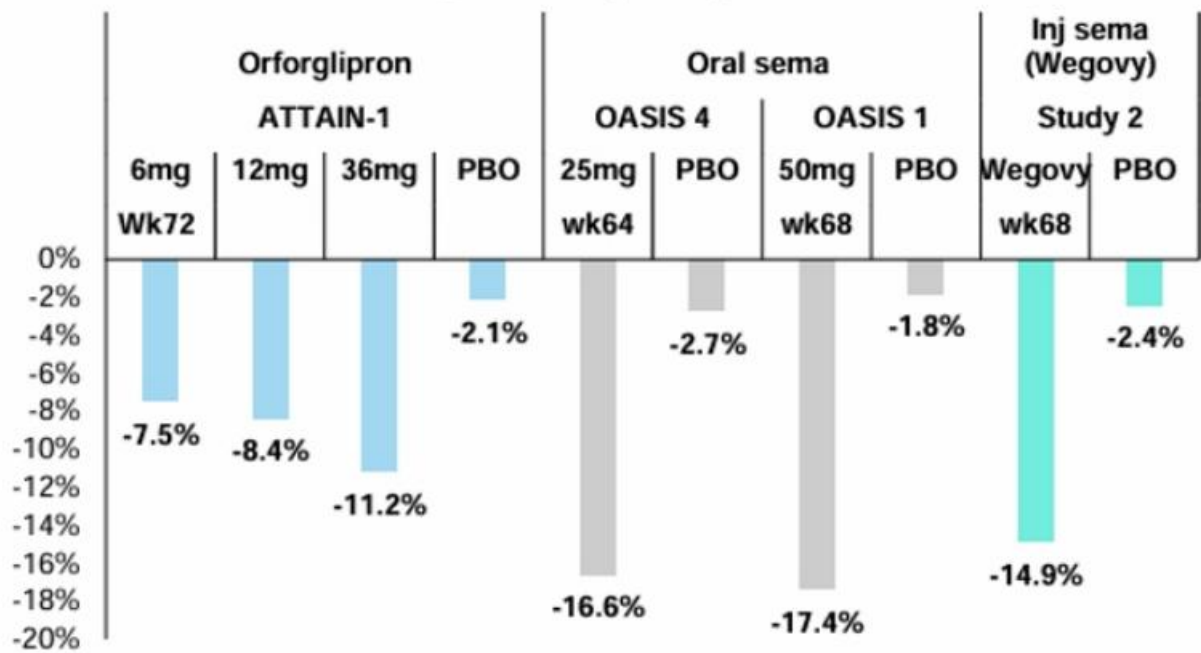
图表 12

HRS-9531、ASC30、orfoglipron和aleniglipron在2026年美国糖尿病协会会议上的结果与先前报告一致；阿斯利康由Justin Smith覆盖，硕迪生物、Biomed industries和歌礼制药未被覆盖  
来源：公司披露，美国糖尿病协会，新英格兰医学杂志，Bernstein分析

| Product             | Foundayo                                                                            | Wegovy Pill                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Generic name        | orforglipron                                                                        | semaglutide                                                                          |
| Company             |  |  |
| Modality            | Small molecule                                                                      | peptide                                                                              |
| Dietary restriction | None                                                                                | Take the med with empty stomach and no drink or eat for 30 mn                        |

图表 13

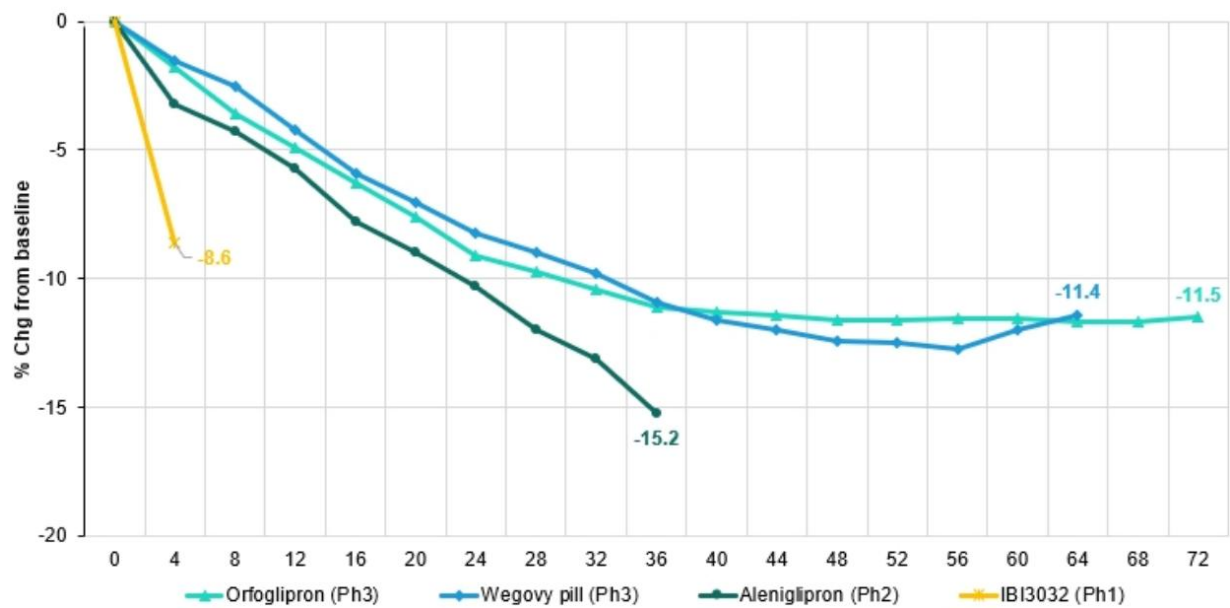
图表10：口服GLP-1之战已在Foundayo和Wegovy口服片之间打响 体重较基线的平均百分比变化



图表 14

来源：公司报告，柳叶刀，新英格兰医学杂志，Bernstein分析

图表11：信达生物的口服GLP-1药物IBI3032在4周内实现安慰剂校正减重-8.6%  
口服GLP-1试验中体重百分比变化比较（安慰剂校正）



图表 15

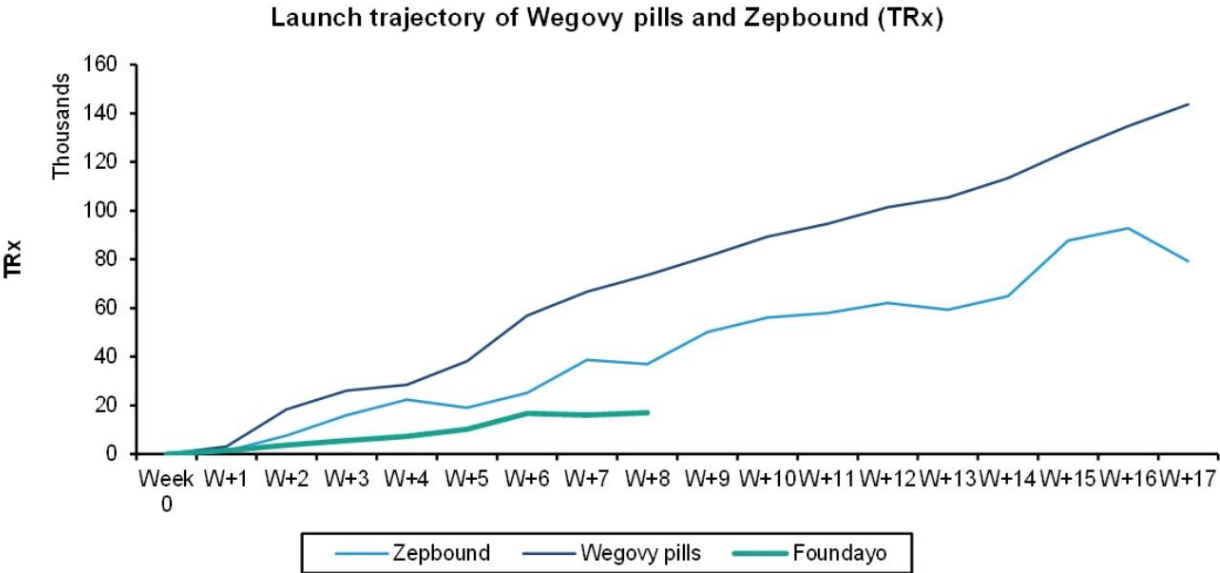
来源：新英格兰医学杂志，美国糖尿病协会，Bernstein分析

图表12：按亚组划分的口服GLP-1减重疗效

来源：公司披露，美国糖尿病协会，新英格兰医学杂志，Bernstein分析

尽管Foundayo于今年早些时候上市且具有差异化的便利性优势，但其处方量增长迄今落后于Wegovy口服片。正如我们的分析师Miki Sogi所指出的，一个潜在原因是熟悉度：口服司美格鲁肽已上市多年，医生和患者对其疗效和安全性更为放心，而Foundayo作为新进入者，仍在建立认知度。这表明礼来可能需要进一步研究于患者和医生教育，以帮助将其便利性优势转化为更强的处方增长。

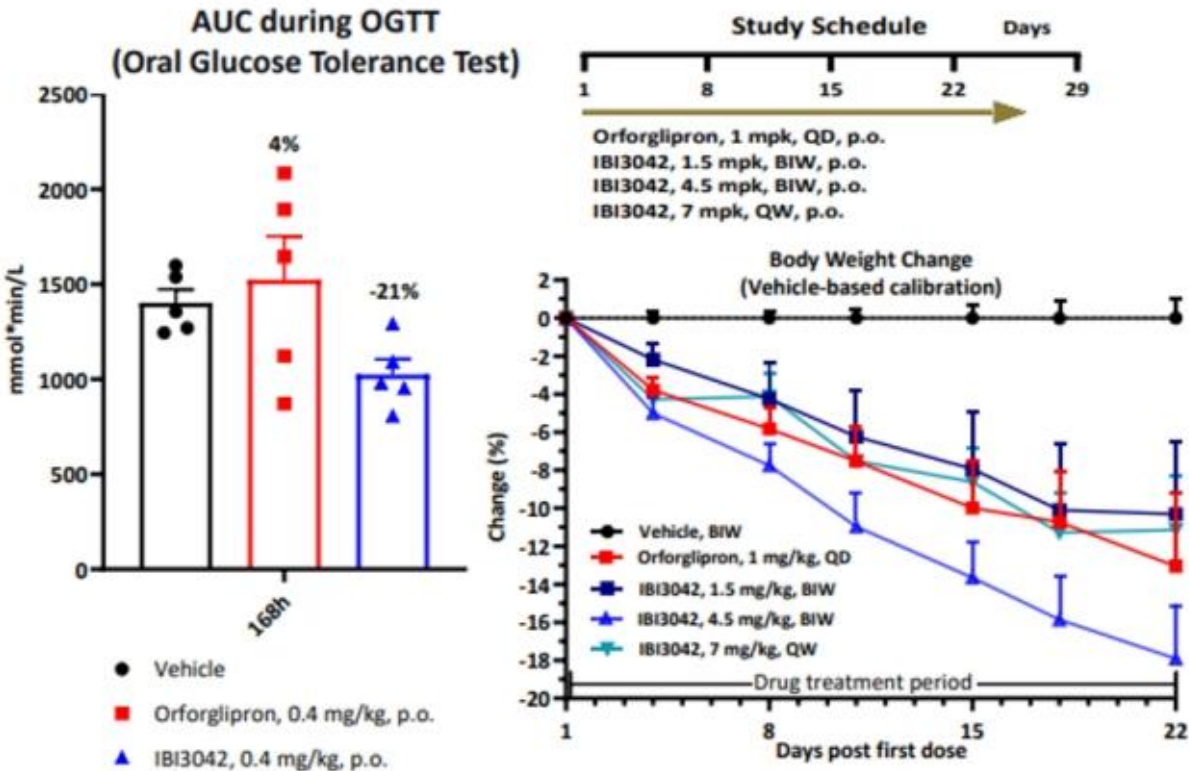
图表13：Foundayo的上市速度远慢于Wegovy口服片：关键差异之一是后者从一开始就是已知实体



图表 16

来源：公司报告，IQVIA，Bernstein分析

除了每日口服疗法，信达生物还在开发IBI3042，这是一种新型的每周一次口服小分子GLP-1受体激动剂。临床前数据表明，IBI3042可实现与礼来每日口服疗法orforglipron相当的减重效果，同时提供每周一次给药的额外便利性。尽管这些发现仍处于动物实验阶段，尚需在人体试验中验证，但IBI3042凸显了业界将口服给药的便利性与更低给药频率相结合的努力，这有可能缩小口服与注射型肥胖症治疗之间的差距。



图表 17

图表14：2026年美国糖尿病协会会议上的IBI3042

P：肥胖症——动物 | 2026年6月5日

2543-P：IBI3042：一种用于2型糖尿病和肥胖症的新型口服每周一次小分子GLP-1受体激动剂（免费）

来源：美国糖尿病协会，Bernstein分析

图表15：IBI3042实现了与orforglipron相当的疗效

长效GLP-1疗法正成为肥胖治疗领域下一个重要的下一代趋势，研发者旨在将给药间隔从每周注射延长至每月一次（Q4W）甚至每季度一次。其基本原理很简单：在保持显著减重疗效的同时，降低给药频率可提高患者的依从性和便利性。在全球项目中，安进的MariTide和辉瑞的beronematide（MET-097i）进展最快，目前均处于3期临床开发阶段。这些重点产品迄今也产生了最令人信服的疗效数据，表明降低给药频率并不一定以牺牲疗效为代价。中国公司也在积极布局长效GLP-1领域。齐鲁制药的ZT002在国内项目中脱颖而出，报告显示每月给药一次，24周时安慰剂校正后的减重幅度约为12%，与全球领先资产大致相当。相比之下，早期阶段的项目，如瑞诺维的RAY1225和歌礼制药的ASC30，迄今显示的疗效较为温和，安慰剂校正后的减重幅度分别为9.4%和6.3%。虽然应谨慎解读跨试验比较，但当前数据表明，beronematide和ZT002代表了长效GLP-1领域领先的疗效特征，并可能为未来的超长效肥胖疗法设定基准。

注：安进和辉瑞由Courtney Breen负责覆盖

图表16：长效GLP-1：每月一次的GLP-1药物疗效正接近领先的每周疗法

重点产品显示出更好的疗效 来源：公司披露，ADA，Bernstein分析

除了更长效的肽类和小分子药物，下一波肥胖创新正在探索全新的模式，旨在延长持久性、降低给药频率，并可能提高疗效。一种新兴方法是抗体-肽偶联物（APC），它将基于GLP-1的肽段附着在抗体上，以显著延长循环时间。通过增加分子大小并利用Fc受体介导的抗体再循环，APC可以大幅延长半衰期，同时保持生物活性。领先的例子是安进的MariTide（AMG 133），这是一种GLP-1激动剂/GIPR拮抗剂APC，在52周时显示出13.7%的安慰剂校正减重效果，并且可以每月给药一次。中国研发者也正在进入该领域，信达生物正在推进IBI3030，这是一种下一代APC，将抗PCSK9抗体与GLP-1R/GCGR/GIPR激动剂活性相结合，突显了多靶点代谢和心血管获益的潜力。

另一个有前景的平台是环状RNA（circRNA），它可能克服传统基于mRNA疗法的一些持久性限制。与线性mRNA不同，circRNA本质上更稳定，可以支持更长时间的蛋白质表达，使其成为长效代谢治疗的有吸引力的选择。PegBio的CR059使用脂质纳米颗粒递送来编码一种GLP-1类似物，设计为每月给药一次。在糖尿病非人灵长类动物的临床前研究中，单次给药后，空腹血糖在两天内下降约31%，在第一周内达到目标水平，并保持控制约一个月。尽管仍处于1期临床开发阶段，该平台展示了RNA疗法如何有可能将肥胖和糖尿病治疗从每周干预转变为每月干预。

基因疗法代表了一种更具雄心的方法。Fractyl Health正在开发一种靶向β细胞的“智能GLP-1”疗法，使用通过内镜超声引导程序递送的腺相关病毒（AAV）载体。该疗法并非重复给药GLP-1药物，而是旨在将胰腺β细胞转化为GLP-1的持续来源，其分泌与代谢信号相关联。在临床前小鼠研究中，一次性治疗在45天内产生了超过25%的体重减轻，表明无需长期给药即可实现高度持久的疗效。

虽然这些技术仍处于比已确立的GLP-1疗法更早期的阶段，但它们展示了肥胖领域如何超越简单地改进每周注射。在这三种方法中，APC目前是临床验证最充分的，但circRNA和基因治疗平台提供了将给药间隔延长至每月一次的远景——或者可能在单次治疗后实现持久的治疗效果。如果成功，这些创新可能会显著重塑肥胖和代谢疾病的长期治疗范式。

注：安进由Courtney Breen负责覆盖

图表17：AMG 133，一种抗体-肽偶联物GLP-1





图表 18

图表18：另一个APC例子是信达生物的IBI3030 来源：ADA，Bernstein分析 来源：公司披露，Bernstein分析

图表19：PegBio开发了circRNA

PegBio

LB: CLINICAL THERAPEUTICS—INCRETIN-BASED THERAPIES | JUNE 05 2026

2832-LB: CR059, a Once-Monthly circRNA-Encoded GLP-1 Analogue, Demonstrates Durable Glycemic Control in T2D Rhesus Monkeys FREE

YA PEI; MICHAEL MIN XU

Check for updates

Diabetes 2026;75(Supplement\_1):2832-LB

<https://doi.org/10.2337/db26-2832-LB>

Split-Screen

Share

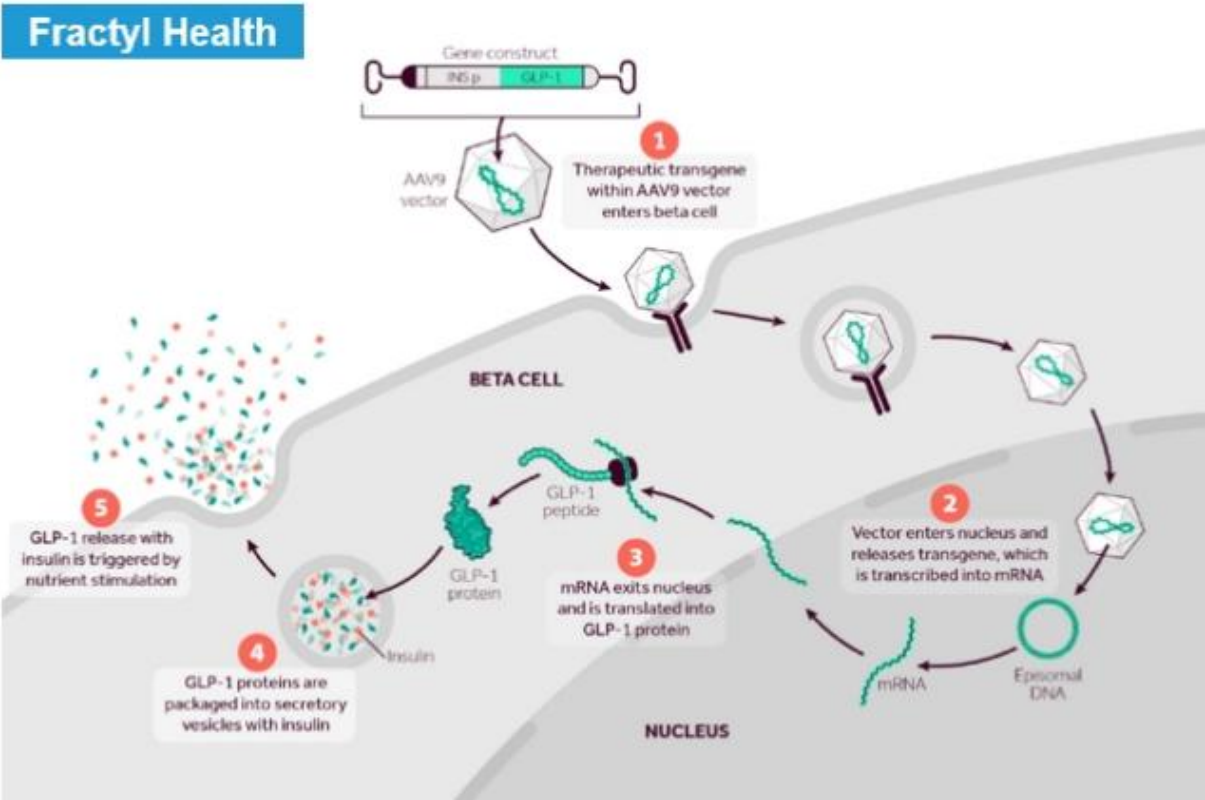
Cite

Get Permissions

图表 19

引言与目标：CR059是一种由环状RNA编码的GLP-1受体激动剂，通过脂质纳米颗粒（LNP）递送，旨在通过每月一次皮下给药实现持续表达和长效代谢控制。本研究评估了CR059在2型糖尿病（T2D）猴子中的降糖效果。

来源：ADA，Bernstein分析 图表20：Fractyl Health推出的一项雄心勃勃的疗法



图表 20

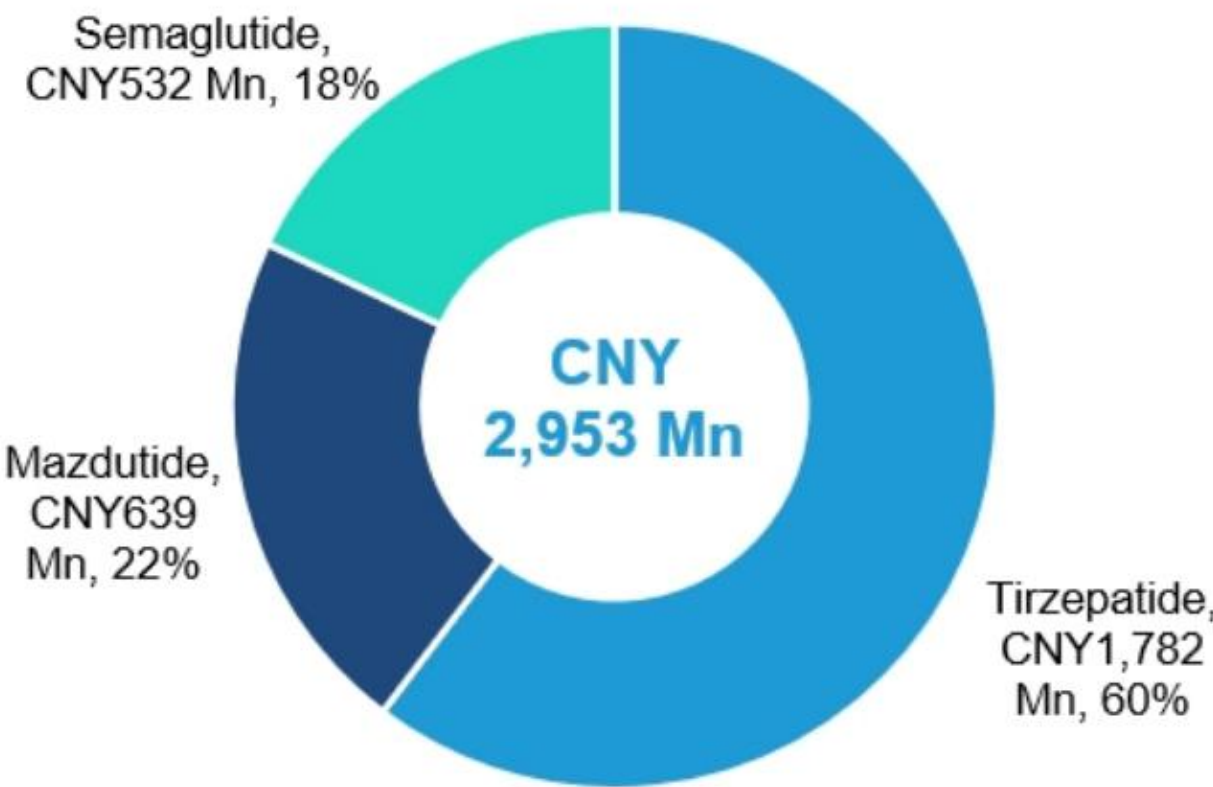
来源：Fractyl Health

第五部分：中国市场动态

尽管围绕在线减肥药销售存在监管噪音，GLP-1零售需求在26年上半年依然强劲。三种主要GLP-1产品——替尔泊肽（TZP）、玛仕度肽（MAZ）和司美格鲁肽（SEMA）——在26年上半年的线上销售持续强劲增长，根据渠道追踪，三者合计线上零售额接近30亿元人民币。5月份，媒体报道显示对减肥药线上销售实施了更严格的控制，包括更严格的处方验证要求以及部分地区对互联网医院处方的限制。然而，GLP-1产品在很大程度上仍然可以获取，因为它们也被批准用于治疗2型糖尿病。尽管这三种产品在6月份均出现环比小幅节奏变化，但我们认为现在断定监管收紧已实质性改变潜在需求趋势还为时过早。

替尔泊肽仍然是品类领导者，而玛仕度肽是26年上半年市场份额的主要增长者。根据我们的渠道数据，TZP在26年上半年产生了约18亿元人民币的零售额，约占追踪GLP-1市场60%的份额。尽管如此，信达生物的MAZ继续从SEMA手中夺取份额，并从3月份起在月销售额上超过了SEMA。按当前趋势，我们估计MAZ在2026年的线上销售额可能达到约13-15亿元人民币。假设线上销售约占零售总额的60-70%，我们认为MAZ的总销售额仍有望实现公司2026年约20亿元人民币的目标。

26年上半年各产品GLP-1线上销售额



图表 21

司美格鲁肽：包括诺和泰和诺和盈

图21：玛仕度肽2026年上半年线上销售额超6亿元人民币，在GLP-1前三名中占据22%份额，位列第二

图22：替尔泊肽近期线上销售额增长最快；玛仕度肽自3月起销售额已超越司美格鲁肽



图表 22

司美格鲁肽：包括诺和泰和诺和盈 来源：魔镜洞察（淘宝+天猫+京东），Bernstein分析  
来源：魔镜洞察（淘宝+天猫+京东），Bernstein分析

我们更新了中国GLP-1市场模型，以反映近期定价趋势和更广泛的治疗范式，价格侵蚀速度快于预期，但被可及市场总规模（TAM）和渗透率的显著扩大所抵消。基于2026年1月开始的定价重置，我们将2030年预期肥胖症平均售价（ASP）假设下调至约270元人民币/月（此前约为430元人民币/月），长期正常化水平约为200元人民币/月。

与此同时，我们通过扩大符合条件的患者群体来扩展可及市场总规模（TAM）。我们之前的模型假设了一个相对较高的用药门槛，仅关注至少有一种合并症的肥胖患者（BMI > 28）。然而，近期的批准支持在更广泛人群中使用减重疗法，包括肥胖患者（无论是否有合并症）以及至少有一种体重相关合并症的超重个体（BMI在24 – 28之间）。反映这一变化，我们现在将这两个群体都纳入TAM。

在扩大人群的同时，我们提高了GLP-1渗透率的假设。真实世界数据显示，使用率正在加速增长，美国超重和肥胖人群的渗透率估计已达10 – 20%并持续上升。2024年的一份报告进一步指出，12%的美国成年人曾使用过GLP-1疗法，其中约6%正在积极使用。基于这些趋势，我们将2030年预期超重/肥胖人群的预测渗透率从8%提高到15%。同时，我们优化了治疗持续时间的假设以更好地反映观察到的行为，将减重的预期持续时间从8个月缩短至3个月，将2型糖尿病的预期持续时间从12个月缩短至10个月。我们还纳入了青少年肥胖作为需求增量驱动因素日益增长的重要性。预计儿童肥胖患病率将比成人增长更快，从目前的约10%上升到2035年预期的18%，而同期成人患病率将从14%上升到18%。

总体而言，虽然更快的价格侵蚀构成逆风，但这被TAM的扩Daiwa更高的GLP-1预期渗透率所充分抵消。因此，我们继续预测中国GLP-1市场将在2030年预期达到约850亿元人民币。在所有关键假设中，超重/肥胖人群的渗透率——目前预测为15%——仍然是最关键和不确定的变量，特别是考虑到目前约1%的低起点。

图23：肥胖症线上渠道价格追踪

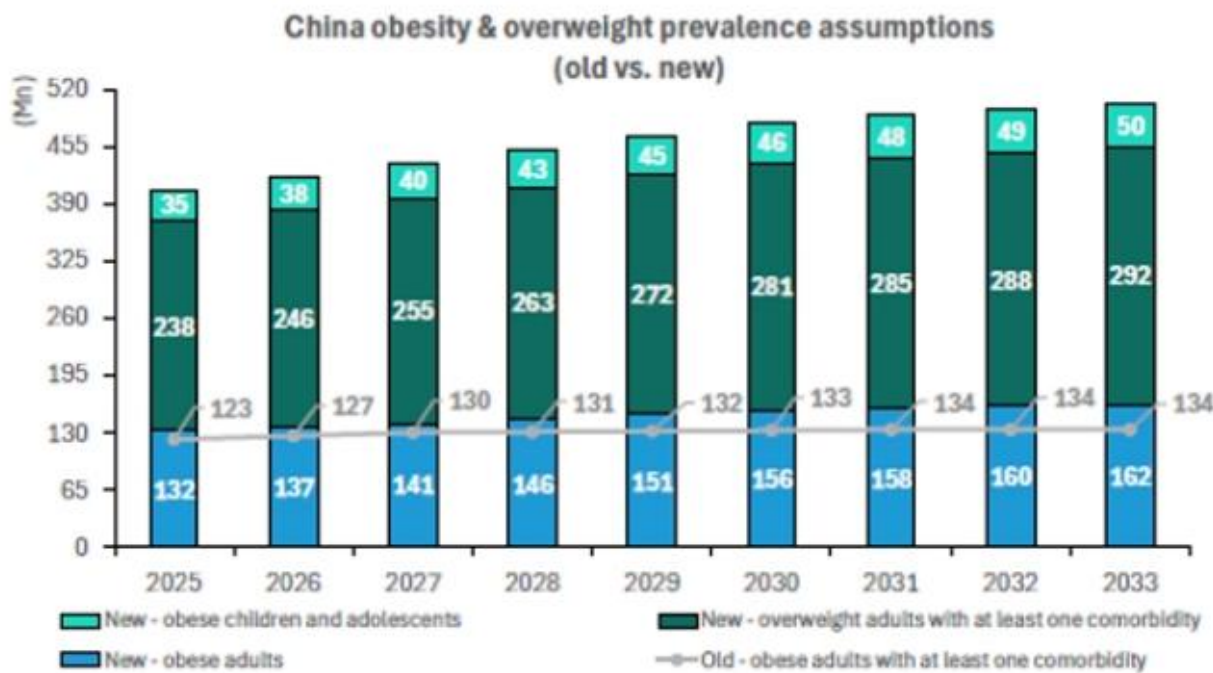
|            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026E                                                                                                                                                                | 2027E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2028E or later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Injections | <div><br/>Tirzepatide (Mounjaro)<br/>▲ Approved in China (May'24 T2D; Jul'24 obesity)<br/>▲ Official commercial launch in China in Jan. 2025</div> <div><br/>Semaglutide (Ozempic &amp; Wegovy)<br/>▲ Approved in China (Apr'21 T2D; Jun'24 obesity)<br/>▲ Launched both Ozempic and Wegovy in China</div> | <div><br/>Mazdutide (IBI362)<br/>▲ Approved in China (Jun'25 obesity) (Nov'25 9mg filed)<br/>▲ Approved in China (Sept'25 T2D)</div> <div><br/>Visepegenatide<br/>▲ Approved in China (Nov'25 T2D; obesity in Ph1/2)</div> | <div><br/>Ecnoglutide<br/>▲ Approved in China (Jan'26 T2D) (Mar'26 obesity)</div> | <div><br/>Ribupatide (HRS-9531)<br/>▲ Filed NDA in Sep'2025 in China, est. launch in 2027E</div> <div><br/>HS-20094<br/>▲ Filed NDA in Jun'2026, est. launch in 2027E</div> <div><br/>Semaolutide biosimilar<br/>▲ China patent expiry in 2026; expected to approve in 2027E</div> | <div><br/>CagriSema<br/>▲ Est. to be approved in China in 2028E+</div> <div><br/>GZR18<br/>▲ Now in Ph3, est. launch in 2028E+</div> <div><br/>BGM0504<br/>▲ Now in Ph3, est. launch in 2028E+</div>                                                                                                                                                                                                                          |
| Oral       | <div><br/>Semaglutide (Rybelsus)<br/>▲ Approved in China (Jan'24 T2D)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | <div><br/>Orfoglipron<br/>▲ NDA submitted in China for both T2D and obesity, est. launch in 2027E</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><br/>Semaglutide (Wegovy pill)<br/>▲ Phase 3 OASIS 3 completed in China, expected approval in 2028E+</div> <div><br/>Oral ribupatide<br/>▲ China Phase 2 trial ongoing, est. launch in 2028E+</div> <div><br/>HRS-7535<br/>▲ Now in Ph3, est. launch in 2028E+</div> <div><br/>VCT220<br/>▲ Now in Ph3, est. launch in 2028E+</div> |

图表 23

来源：京东，Bernstein分析

图24：司美格鲁肽和替尔泊肽已纳入中国国家医保目录，我们认为玛仕度肽将从2027年预期开始纳入



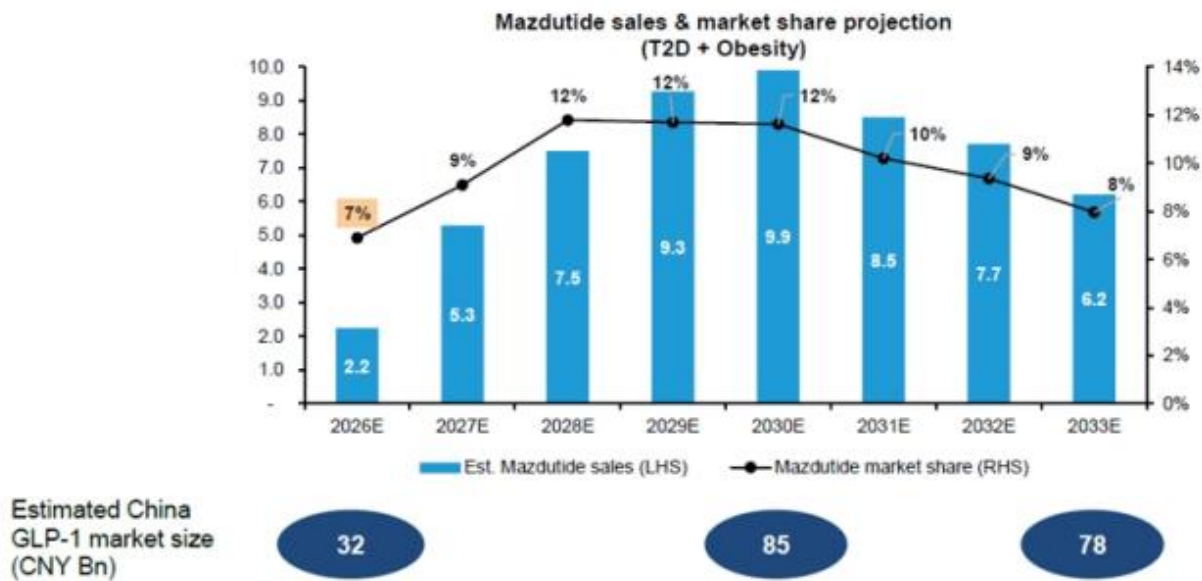


图表 24

图表中玛仕度肽价格来自线上渠道，因该产品尚未纳入国家医保目录 来源：国家医保目录，Bernstein分析

2027年标志着主要GLP-1产品上市浪潮的开始。继司美格鲁肽（诺和泰、诺和盈和诺和忻）、替尔泊肽（穆峰达）和玛仕度肽（信尔美）初步上市后，中国GLP-1市场预计将在2027年预期迎来一波集中的新进入者，包括恒瑞的HRS-9531、豪森的HS-20094、奥格列仑（口服GLP-1）以及专利到期后的第一波司美格鲁肽生物类似药。预计管线将在2028年预期及以后进一步拓宽，可能推出卡格列美肽、口服司美格鲁肽（诺和盈片剂）、口服HRS-9531、GZR18、BGM0504及其他后期候选药物，从而扩大注射和口服治疗选择。我们认为，这一上市浪潮可能会加速市场渗透和患者可及性，同时推动向竞争性多参与者的格局转变。随着竞争强度增加，差异化可能将从单纯的血糖和减重疗效转向口服便利性、身体成分改善和定价等因素。

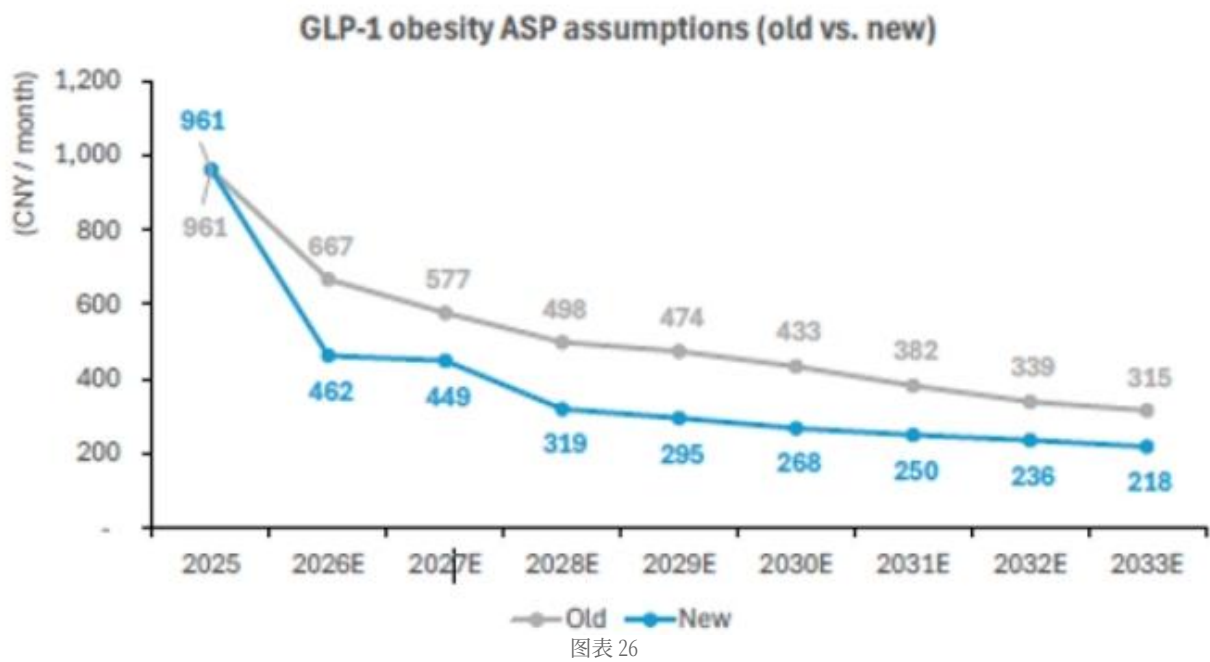
图25：继玛仕度肽上市后，国内GLP-1市场预计将从2027年及以后迎来一波集中的新产品上市浪潮



图表 25

派格生物、信达生物和甘李药业未覆盖 来源：公司披露，ClinicalTrials.gov，Pharmcube，Bernstein估计与分析

图26：2030年预期中国GLP-1市场关键假设更新



a. 我们之前的模型未纳入超重人群

图27：中国肥胖与超重患病率假设（旧版 vs 新版）

a. 我们之前的模型未纳入超重人群

来源：公司披露，《糖尿病、肥胖与代谢》，美国国立卫生研究院，MedNexus，Bernstein分析与估计

图28：玛仕度肽更新后的销售轨迹

来源：Bernstein估计与分析

图29：中国肥胖症市场GLP-1药物平均售价假设（旧版 vs 新版）

来源：公司披露，国家医疗保障局，Pharmcube，京东，Bernstein分析与估计